

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Medicolegal —

PACIENTE

Jorge Eliécer Salazar Pinzón

DOCUMENTO

CC 79555111

FECHA NACIMIENTO

08/11/1980

EDAD

46 años, 2 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Tecnólogo

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

12/01/2027

ORDEN N°

Auto del 2026-05-20

PROTOCOLO APLICADO

peritaje_medicolegal_adulto

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

ALCANCE DEL INFORME

Limitaciones y propósito del presente documento

Lectura del informe

Este informe describe el funcionamiento cognitivo y conductual del evaluado en el momento de la evaluación. No constituye por sí mismo un dictamen médico-legal ni de imputabilidad. La interpretación de los hallazgos en el marco de un proceso judicial o administrativo es competencia exclusiva de la autoridad o el equipo pericial al que se remite, quienes deberán integrarlo con la totalidad del acervo probatorio.

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Jorge Eliécer Salazar Pinzón	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 79555111	Ocupación:	Técnico electricista (incapacitado por el ...
Fecha de nacimiento:	08/11/1980	Ciudad:	Bogotá, D.C.
Edad:	46 años, 2 meses	Acompañante:	Esposa Diana Ramírez
Sexo:	Masculino	Remite:	Juzgado 14 Laboral del Circuito — Rad. 2...
Escolaridad:	Tecnólogo	EPS / Asegurador:	Sanitas EPS

MOTIVO DE CONSULTA

PERITAJE NEUROPSICOLÓGICO ordenado por Juzgado 14 Laboral del Circuito. Paciente sufrió TEC moderado en accidente laboral el 2025-08-15 (caída de 4 metros). Demanda en curso contra la empresa constructora. La evaluación es para DETERMINAR SECUELAS COGNITIVAS y capacidad laboral residual.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: peritaje_medicolegal_adulto

Prueba	Dominio	Dur.
VOCABULARIO	Comprensión Verbal	—
COMRENSIÓN	Comprensión Verbal	—
CONSTRUCCIÓN CUBOS	Organización Perceptual	—
FIG. INCOMPLETAS	Organización Perceptual	—
HISTORIETAS	Organización Perceptual	—
INFORMACIÓN	Comprensión Verbal	—
LETRAS Y NÚMEROS	Memoria de Trabajo	—
ROMPECABEZAS	Organización Perceptual	—
Figura de Rey	Memoria Visuoespacial	—
Inventario de Beck BDI-II	Socioemocional - Depresión	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica. Paciente colaborador.

Atención y concentración

Atención sostenida severamente comprometida. TMT-A normal pero TMT-B en percentil <1. Stroop con alta interferencia (errores x3 sobre lo esperado). Estilo de respuesta lento-cauteloso, sugerente de déficit en velocidad de procesamiento más que impulsividad.

Memoria

Memoria de trabajo auditiva descendida (dígitos inversos en percentil 16). Memoria verbal con curva de aprendizaje aplanada y alta tasa de intrusiones (FCRO Rey percentil 25).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje expresivo conservado pero con latencias aumentadas. Comprensión auditiva intacta para material concreto, descendida para inferencias. Discurso con pausas y autocorrecciones frecuentes.

Funciones ejecutivas

Funciones ejecutivas GLOBALESMENTE descendidas. WCST con 4 categorías completadas (esperado 6). Errores perseverativos aumentados. Flexibilidad cognitiva severamente afectada (TMT-B).

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo: F07.2 - Síndrome post-concusional + demanda laboral activa

VALIDEZ DE SÍNTOMAS Y ESFUERZO

Consideración crítica para informe pericial

Advertencia metodológica

No se incluyeron pruebas formales de validez de síntomas (PVT/SVT) en esta evaluación. La interpretación se realiza asumiendo que el paciente colaboró con esfuerzo óptimo, según la observación clínica directa. Para usos forenses, periciales o cuando hay incentivos secundarios evidentes, se recomienda complementar este informe con pruebas dedicadas de validez (p. ej. Rey-15, TOMM, MMPI-2-RF F/Fp scales).

RESULTADOS CUANTITATIVOS

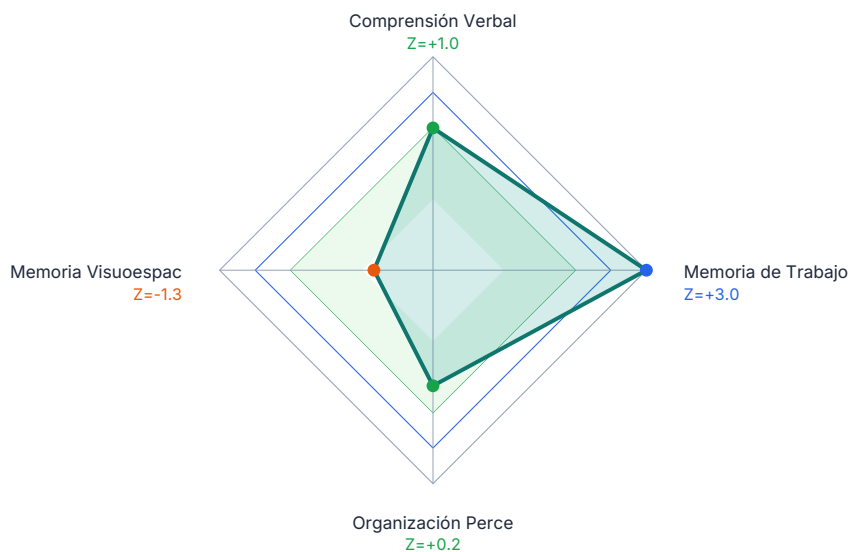
Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

Inventario de Be

18

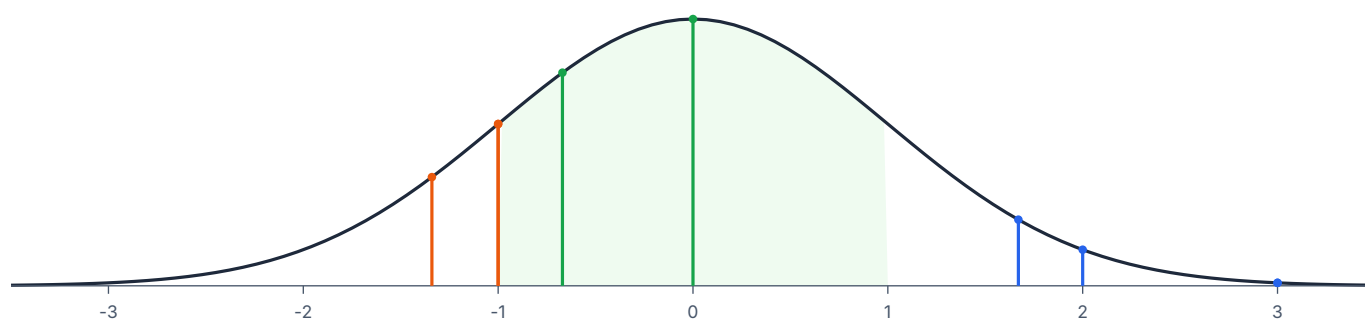
Leve

Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 9 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
VOCABULARIO							-0.67
COMRENSIÓN							+2.00
CONSTRUCCIÓN CUBOS							-1.00
FIG. INCOMPLETAS							+0.00
HISTORIETAS							+3.00
INFORMACIÓN							+1.67
LETRAS Y NÚMEROS							+3.00
ROMPECABEZAS							-1.00
Figura de Rey							-1.34
Inventario de Beck BDI-II							-5.47

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z<-1 sugiere debilidad. Z>+1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
VOCABULARIO	32	8	-0.67	Promedio
COMRENSIÓN	28	16	+2.00	Superior
CONSTRUCCIÓN CUBOS	24	7	-1.00	Promedio
FIG. INCOMPLETAS	19	10	+0.00	Promedio
HISTORIETAS	22	19	+3.00	Superior
INFORMACIÓN	25	15	+1.67	Superior

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
LETRAS Y NÚMEROS	21	19	+3.00	Superior
ROMPECABEZAS	20	7	-1.00	Promedio
Figura de Rey	25	-1	-1.34	Límitrofe
Inventario de Beck BDI-II	18	18	-5.47	Leve

CONSIDERACIONES DE ACULTURACIÓN Y ESCOLARIDAD

Modulación cultural y educativa de los hallazgos

Los baremos empleados corresponden a la población colombiana cuando estuvo disponible (ENI-2, Neuronorma Colombia, Arango-Lasprilla & Rivera, 2017). Para pruebas sin normas locales se utilizaron las referencias originales, ajustando la interpretación al perfil sociocultural y escolar del evaluado. En contextos forenses esta consideración cobra especial relevancia: el desempeño puede verse modulado por escolaridad <8 años, bilingüismo, lengua materna no española o lateralidad mixta.

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: memoria visuoespacial (moderadamente disminuido, $Z=-1.3$). Por su parte, destacan como áreas preservadas o por encima del promedio: memoria de trabajo (muy alto, $Z=+3.0$); comprensión verbal (alto, $Z=+1.0$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Figura de Rey ($Z=-1.34$, límitrofe); CONSTRUCCIÓN CUBOS ($Z=-1.00$, promedio); ROMPECABEZAS ($Z=-1.00$, promedio). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido / superior

- Figura de Rey — límitrofe ($Z=-1.34$)
- CONSTRUCCIÓN CUBOS — promedio ($Z=-1.00$)
- ROMPECABEZAS — promedio ($Z=-1.00$)
- HISTORIETAS — superior ($Z=+3.00$)
- LETRAS Y NÚMEROS — superior ($Z=+3.00$)
- COMPRENSIÓN — superior ($Z=+2.00$)
- INFORMACIÓN — superior ($Z=+1.67$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Jorge. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En AdWAISV, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En AdWAISC, tu rendimiento fue muy por encima del promedio. En AdWAISCC, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.

Fortalezas (lo que se hace bien)

- En AdWAISV, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdWAISC, tu rendimiento fue muy por encima del promedio.
- En AdWAISCC, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdWAISFI, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdWAISHI, tu rendimiento fue muy por encima del promedio.

¿Qué recomendamos?

Recomendación: [LABORAL] Paciente presenta SECUELAS COGNITIVAS SIGNIFICATIVAS compatibles con síndrome post-concusional crónico. Capacidad laboral residual estimada: 40-50% de su nivel pre-lesional. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: [LABORAL] Implicaciones para la demanda: Las alteraciones en funciones ejecutivas y memoria documentadas SON CONSISTENTES con el TEC moderado del 2025-08-15 (mecanismo plausible, temporalidad coherente, perfil neuropsicológico típico). (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: [LABORAL] Limitaciones específicas: no apto para trabajo en alturas, no apto para tareas que requieran alta velocidad de procesamiento o toma rápida de decisiones en condiciones de riesgo. Requiere supervisión y pausas estructuradas. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: [LEGAL] Documentación completa disponible para el juzgado. Se anexa: batería administrada, resultados normativos, análisis de validez, correlación anátomo-clínica, y respuesta a cada pregunta del auto interlocutorio. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos).

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F07

Impresión diagnóstica: F07.2 - Síndrome post-concusional + demanda laboral activa

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

Familiar

- Psicoeducación a esposa e hijos sobre el perfil de secuela, manejo conductual en casa, expectativas realistas de recuperación.

General

- [LABORAL] Paciente presenta SECUELAS COGNITIVAS SIGNIFICATIVAS compatibles con síndrome post-concusional crónico. Capacidad laboral residual estimada: 40-50% de su nivel pre-lesional.
- [LABORAL] Implicaciones para la demanda: Las alteraciones en funciones ejecutivas y memoria documentadas SON CONSISTENTES con el TEC moderado del 2025-08-15 (mecanismo plausible, temporalidad coherente, perfil neuropsicológico típico).
- [LEGAL] Documentación completa disponible para el juzgado. Se anexa: batería administrada, resultados normativos, análisis de validez, correlación anátomo-clínica, y respuesta a cada pregunta del auto interlocutorio.
- [LABORAL] Limitaciones específicas: no apto para trabajo en alturas, no apto para tareas que requieran alta velocidad de procesamiento o toma rápida de decisiones en condiciones de riesgo. Requiere supervisión y pausas estructuradas.

Terapéutica

- Indispensable: programa de rehabilitación neuropsicológica de 6 meses (mínimo 24 sesiones) con foco en funciones ejecutivas y estrategias compensatorias de memoria.
- Tratamiento farmacológico de la sintomatología depresiva-ansiosa por psiquiatría (ISRS). Psicoterapia breve de apoyo.